

Insuficiencia renal aguda

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

Aumento progresivo de U. C v en general disminución del flujo urinario

PRERREANAL: Hipoperfusión renal (Necrosis Tubular Aguda):

Deshidratación

Shock

Sepsis

Hemorragias

Quemaduras

Insuficiencia cardíaca

Sme. Nefrótico

Insuficiencia hepática

Cirugía cardiovascular

RENAL:

Injuria parenquimatosa

Endógenos:

Hemoglobinuria (Ej: transfusión de sangre incompatible)

Mioglobinuria (Ej: traumatismo grave, polimiositis, dermatomiositis)

Hiperuricemia

Hiperfosforemia (Ej: Sme. Lisis Tumoral Aguda)

Hipercalcemia

Exógenos:

Acción directa:

ATB (gentamicina, amikacina, anfotericina B, sulfamidas, cisplatino, ciclosporina, metotrexato)

Sustancias de contraste

Metales pesados (mercurio, bismuto)

Por Hipersensibilidad:

ATB (penicilina, ampicilina, cefalotina, rifampicina, TMP-sulfa)

AINEs (naproxeno, ibuprofeno)

Anticonvulsivantes (DFH, FB)

Diuréticos (furosemida, tiazidas)

Otros (indometacina, azatioprina, allopurinol)

Infecciones:

Pielonefritis aguda

Enfermedad glomerular y vasculitis:

SUH

Púrpura Schölein-Henoch

Glomerulonefritis

Obstrucción renovascular

POSTREANAL: Obstrucción de la vía urinaria

Exámenes complementarios:

Imprescindibles:

Hemograma: Anemia; por defecto en la producción medular, disminución de la vida media, diátesis hemorrágica

Urea: aumentada

Creatinina: aumentada

Ionograma: hiponatremia dilucional, Hiperkalemia cuando $<<$ del FG

EAB: Acidosis metabólica: con anión gap elevado, debido a falta de excreción renal y $>$ de la producción

Examen de orina: densidad baja, hematuria, proteinuria, leucocituria y cilinduria

Tele Rx de tórax, ECG en caso de anuria (IC congestiva, arritmias por hiperpotasemia?).

Dentro de las primeras 24 hs

Calcio (Hipocalcemia: en general es leve y secundaria a la hiperfosfatemia), fósforo (Hiper fosfatemia: por disminución de la excreción renal de fosfatos, por lisis celular), ácido úrico, glucemia, magnesio, proteinograma, colesterol, triglicéridos, urea en orina, creatinina en orina, ionograma en orina.

Electivos

Ecografía renal, proteinuria de 24 hs, urocultivo, colageograma y otros según sospecha diagnóstica.

Eventuales

Biopsia renal, etc.

Tratamiento

1. Furosemida: podrían ser beneficiosos en la etapa de prevención. Una vez instalada la IRA no anúrica la podría ser beneficiosa solo para mantener un flujo urinario mayor: 1-5 mg/kg/dosis EV
2. Aporte hídrico = P.I. + P.C. + diuresis. Objetivo: balance hídrico neutro.
3. Hiponatremia: restricción hídrica. Hiponatremia < 120 mEq/l que no responda a la restricción hídrica o presente síntomas: corrección.
4. Hiperkalemia: Restricción del K de la dieta y soluciones parenterales, favorecer el ingreso del K a la célula con CHO_3 según estado ácido base; glucosa + insulina, aumentar la excreción extrarrenal con resinas de intercambio, corregir la hipocalcemia y la hiponatremia pues ambas situaciones aumentan la toxicidad cardíaca.
5. Hiperfosfatemia: restricción de la ingesta, quelantes del fósforo de la dieta.
6. Hipocalcemia: en general es leve y corregida al controlar la hiperfosfatemia. Si hay síntomas se administra gluconato de calcio al 10%
7. Soporte nutricional: aporte calórico adecuado, dieta normoproteica con 70% de las proteínas de alto valor biológico (SNG si es necesaria).
8. **Sustitutivo o de reemplazo:** DIALISIS: Indicaciones: Hipervolemia - Insuficiencia cardíaca - Edema agudo de pulmón, Hiperkalemia grave, Ac metabólica intratable, Nefropatía hiperuricémica, Hipocalcemia sintomática con hiperfosfatemia (Ej: Sme. de Lisis Tumoral), Anuria de más de 48 horas, Sme. Urémico, Intoxicación